



Malang, 15 Juli 2024

Nomor : 968/I-PB/DIR/VII/2024
Lampiran : 10 Halaman
Perihal : Umpan Balik Capaian Iterasi Obat s/d Juni 2024

Kepada Yth.

1. SMF Penyakit Dalam
 2. SMF Jantung
 3. SMF Jiwa
 4. SMF Paru
 5. SMF Saraf
 6. SMF Urologi
- di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan NO 2186/VII-05/0724 perihal Umpan Balik Utilisasi **Kontrol Ulang RJTL dan Iterasi Obat**, dilampirkan data **Top 10 diagnosa kunjungan rawat jalan dengan diagnosa PRB yang berpotensi untuk dilakukan rujuk balik jika kondisinya tervalidasi PRB (benar diagnosa, benar obat dan benar stabil)**. Maka ditetapkan target iterasi disetiap FKRTL dimana **Target Iterasi** RS Prima Husada sebesar **1.012 resep** dan sampai dengan bulan **Juni 2024** hanya tercapai sejumlah **160 resep sehingga terdapat kekurangan sebesar 852 resep**. Berikut kami lampirkan pembagian target Iterasi pada masing-masing DPJP berdasarkan jumlah potensi PRB dan Iterasi untuk mempermudah DPJP dalam penentuan dan monitoring

Diharapkan Rumah Sakit dapat melaksanakan Program Rujuk Balik dan Iterasi secara optimal serta mengupayakan capaian rekrutmen PRB 100% dan Iterasi sesuai target sampai dengan bulan **Oktober 2024** (saat kredensialing perpanjangan PKS dengan BPJS Kesehatan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah



LAMPIRAN

1. Pengertian :

Iterasi merupakan program pengambilan obat kronis di Rumah Sakit dengan menggunakan resep obat kronis sebelumnya sehingga pasien tidak perlu bertemu/tatap muka Dokter Spesialis / Sub Spesialis

2. Sasaran :

Pasien dengan penyakit kronis stabil dan mendapatkan obat kronis (Apotek online) tetapi obat tidak masuk dalam program PRB

3. Aturan :

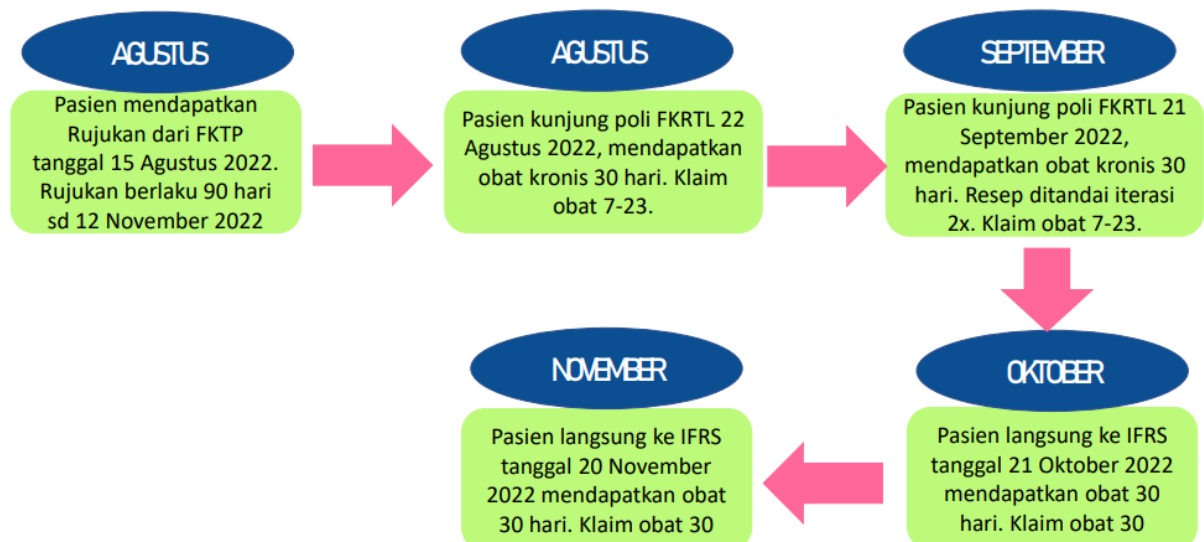
Mendapatkan resep obat untuk 30 hari dengan resep yang sama dari resep bulan sebelumnya (hanya obat yang masuk dalam Apotek online), maksimal iterasi 2X **dalam rujukan**

4. Perhitungan capaian iterasi berdasarkan pelayanan resep iterasi yang terealisasi



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SKEMA PELAYANAN ITERASI OBAT KRONIS





5. Capaian Rekrutmen Iterisasi Juni 2024

NO	NAMA DPJP	TARGET ITERISASI 2024	TARGET PER BULAN	JUMLAH CAPAIAN S/D JUNI 2024	KEKURANGAN ITERISASI
1	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	209	35	0	-209
2	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	125	21	2	-123
3	DR ZORAIDA DWI WAHYUNI, SP. PD	86	14	8	-78
4	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	76	13	0	-76
5	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	76	13	81	Sudah tercapai
6	DR IRA SETYA WATY SP JP	24	4	24	Sudah tercapai
7	DR MIFTAKHUL HUDA SP KJ	28	5	0	-28
8	DR DIDID ROESNO, Sp.KJ	28	5	0	-28
9	DR. ANDY SP. P	82	14	0	-82
10	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	11	2	0	-11
11	DR DEWI MAHARANI SP. S	76	13	14	-62
12	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	76	13	0	-76
13	DR AKHMAD SYAHRIR SP N	76	13	31	-45
14	DR PRADANA SP U	22	4	0	-22
15	DR EDI WIBOWO SP U	17	3	0	-17



6. Kriteria Stabil Sembilan Diagnosa PRB



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Rekomendasi Organisasi Profesi (IDI dan Perhimpunan Terkait) tentang Kriteria
Stabil 9 Kasus Pasien Rujuk Balik (PRB)

A. Epilepsi

Rekomendasi	PERDOSSI
Klinis	1. Bebas serangan selama 6 bulan 2. Telah tercapai dosis rumatan obat anti epilepsi 3. Tidak ada efek samping obat 4. Tidak ada komorbid
Catatan	1. Jenis OAE yang tersebut dalam resep pasien harus tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 2. Obat yang diberikan untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari setiap kali peresepan dan harus sesuai dengan standar obat formularium nasional. 3. Perubahan / penggantian obat hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis / sub spesialis yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 4. Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan
Daftar Pustaka	Permenkes Nomor 5 tahun 2014, Panduan praktik klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

B. Stroke

Rekomendasi	PERDOSSI
Klinis	1. Kondisi pasien stabil walaupun masih didapatkan sekuele stroke infark atau hemoragik 2. Eksplorasi faktor risiko stroke sudah selesai dilakukan (pengukuran tekanan darah, perekaman EKG dan pemeriksaan laboratorium darah berupa profil lipid, gula darah, kadar asam urat) 3. Faktor risiko yang ada pada pasien terkendali: a. Tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg (bagi yang memiliki riwayat diabetes melitus), dan kurang dari 140/90mmHg (bagi yang tidak memiliki diabetes melitus). b. Gula darah puasa antara 80 – 130 mg/dL c. Kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dL (bagi yang memiliki riwayat penyakit Jantung coroner, dan kurang dari 130 mg/dL (bagi yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung coroner). d. Kadar asam urat kurang dari 6 mg/dL (perempuan) dan



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

	kurang dari 7 mg/dL (laki-laki) 4. Tidak ada faktor risiko lain selain yang disebut di atas (misalnya kelainan sel darah, AVM, atrial fibrilasi, dll) 5. Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi.
Catatan	1. Obat yang diberikan untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari setiap kali peresepan dan harus sesuai dengan standar obat formularium nasional. 2. Perubahan / penggantian obat hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis / sub spesialis yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 3. Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan
Daftar Pustaka	PNPK Stroke, 2019. Perdossi Guideline stroke, 2011

C. Penyakit Jantung Hipertensi

Rekomendasi	PAPDI dan PERKI
Klinis	1. Tidak ada tanda gagal jantung (kongestif) berupa sesak napas atau nyeri dada dalam observasi selama 3 bulan 2. Tidak ada aritmia 3. Tekanan darah terkontrol baik pada waktu istirahat maupun aktivitas (TD < 140/90 mmHg) dalam waktu 3 bulan 4. Tidak terdapat keterbatasan aktivitas berupa sesak napas dan/atau nyeri dada selama observasi 3 bulan
Catatan	Penunjang Medis Echocardiografi 6 bulan sekali
Daftar Pustaka	PERKI. 2016. Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

D. Pasca Infark Miokardium (STEMI dan NSTEMI/UAP)

Rekomendasi	PERKI dan PAPDI
Klinis	1. Telah dilakukan revaskularisasi (PCI/CABG) sesuai indikasi 2. Klinis pasien stabil dengan gejala nyeri dada/angina maksimal CCS kelas 1 selama evaluasi 3 bulan. 3. Kapasitas fungsional sesuai dengan NYHA I-II 4. Sudah mendapatkan terapi dual antiplatelet (aspirin dan clopidogrel) 5. Sudah mendapatkan beta blocker dengan dosis optimal dengan target nadi istirahat < 70 kali permenit 6. Telah mendapatkan obat golongan statin intensitas tinggi yang akan dilanjutkan di FKTP 7. Telah mendapatkan obat golongan ACE-Inhibitor atau ARB jika kontraktilitas ventrikel kiri menurun (EF < 40 %) atau hipertensi 8. Tekanan Darah Terkontrol TD < 140/90 mmHg
Catatan	Pasien tidak dirujuk balik jika pasien masih memerlukan ticagrelor (brilinta) paska PCI. Pasien segera dirujuk ulang ke FKTL jika ada perburukan nyeri dada dan obat-obatan tidak bisa disediakan di FKTP secara lengkap.
Daftar Pustaka	PERKI. 2016. Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

E. Angina Pektoris Stabil

Rekomendasi	PERKI dan PAPDI
Klinis	1. Telah dilakukan revaskularisasi (PCI/CABG) sesuai indikasi 2. Tidak ada sesak nafas atau keluhan nyeri dada saat beraktifitas. 3. Sudah mendapat antiplatelet (single antiplatelet atau dual antiplatelet pada pasien paska PCI), beta bloker dosis optimal dan obat golongan statin intensitas tinggi
Catatan	-
Daftar Pustaka	PERKI. 2016. Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

F. Gagal Jantung Kronik

Rekomendasi	PERKI dan PAPDI
Klinis	1. Pasien bebas keluhan sesak nafas (NYHA Fc I-II) selama observasi 3 bulan 2. Volume cairan tubuh tidak bertambah selama 3 bulan berturut-turut 3. Secara hemodinamik stabil dengan kriteria : tekanan darah > 90/60 mmHg dengan produksi urin tercapai sesuai klinis. 4. Penyebab gagal jantung akut sudah teridentifikasi dan teratasi 5. Telah mendapatkan terapi gagal jantung sesuai dengan pedoman tatalaksana gagal jantung dan memantau klinis pasien agar tetap dalam keadaan euvolemik
Catatan	Bila terdapat kriteria tidak stabil berikut , maka harus dirujuk kembali ke FKTL : 1. Ada perburukan sesak nafas yang progressif 2. Terlihat tanda penumpukan cairan tubuh (JVP) meningkat, terdapat ronki basah di paru, asites bertambah, edema kaki) yang tidak membaik dengan furosemid oral atau restriksi cairan. Pasien tidak dirujuk balik apabila : 1. Menonsumsi warfarin yang membutuhkan pemeriksaan darah INR (International Normalized Ratio), misalnya pasien dengan komorbid atrial fibrilasi atau paska operasi katup jantung 2. Pasien yang memerlukan obat-obatan lain yang tidak termasuk dalam Fornas PRB (misalnya ivabradin, sildenafil dan beraprost/dorner) karena hanya tersedia di FKRTL 3. Pasien gagal jantung tidak dirujuk balik jika terpasang device ICD, CRT, CRTD, LVAD atau alat pendukung sirkulasi mekanik lain Semua kasus rujuk balik penyakit jantung diatas, setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi.
Daftar Pustaka	-



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

G. Diabetes Mellitus

Rekomendasi	PAPDI dan PERKENI
Klinis	1. GDP 80-130 mg/dl 2. GD 2PP < 180 mg/dl 3. HbA1c < 7% (waktu pemeriksaan tiap 6 bulan sekali) 4. Tekanan darah sistolik < 140 mmHg 5. Tekanan darah diastolik < 90 mmHg 6. Kolesterol LDL < 100 (<70 bila risiko KV sangat tinggi) 7. Kolesterol HDL : Laki-laki > 40, Perempuan > 50 8. Tidak ada komplikasi akut dan/atau kronik (makrovaskular dan mikrovaskular) yang masih membutuhkan diagnosis dan tatalaksana lebih lanjut di FKTL. 9. Pada Diabetes Mellitus yang terkontrol dengan insulin, dipastikan tersedia insulin dengan jenis dan cara kerjanya yang sesuai di FKTP. 10. Bukan Diabetes Gestasional dan/atau Diabetes Tipe Lain
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan.
Daftar Pustaka	Permenkes Nomor 5 Tahun 2014, Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer PB PERKENI. 2015. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Type 2 di Indonesia 2015 ADA. 2018. Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Vol.41, Supplement 1.

H. Hipertensi

Rekomendasi	PAPDI, PERHI, dan PERNEFRI
Klinis	1. Tekanan darah < 140/90 mmHg, dalam waktu 3 bulan 2. Tidak ada penyakit penyerta lain 3. Tidak terdapat <i>Hypertension Mediated Organ Damaged</i> (HMOD), yaitu Payah Jantung, Penyakit Ginjal Kronik stadium III-V (eGFR < 60 ml/min), Penyakit Jantung Koroner, Stroke, Penyakit Vaskular Perifer, aritmia dan/atau Atrial Fibrilasi. 4. Bukan Hipertensi Sekunder, Hipertensi Pulmonal, dan/atau Hipertensi pada kehamilan 5. Dianjurkan untuk mengukur TD sendiri di rumah (PTDR) atau di fasilitas kesehatan terdekat 6. Disarankan bahwa Penatalaksanaan Hipertensi di FKTP adalah Hipertensi derajat 1 (TD 140 -150/90-99 mmHg dengan Tahap 1 (tidak berkomplikasi dengan 1-2 faktor risiko)
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

	dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan.
Daftar Pustaka	Permenkes Nomor 5 Tahun 2014, Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Primer. Whelton et al. 2017. Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults. AHA. 2017. DOI: 10.1161/HYP.0000000000000065

I. Asma

Rekomendasi	PAPDI dan PDPI
Klinis	- Asma stabil dan terkontrol menurut <i>Asthma Control Test</i> ≥ 20 atau secara klinis apabila pasien dalam 4 minggu memenuhi seluruh parameter gejala dalam '<i>Asthma Symptoms Control</i>' sebagai berikut: - Tidak ada gejala harian asma lebih dari 2x seminggu - Tidak terbangun pada malam hari akibat sesaknya - Tidak memerlukan obat pelega lebih dari 2x seminggu - Tidak ada keterbatasan aktivitas fisik karena asmanya - Asma ringan dan sedang yang stabil, yaitu tidak membutuhkan obat-obat berikut : - Kortikosteroid inhalasi dosis sedang hingga tinggi (untuk dewasa budesonide >400 mcg/hari, flutikason > 250 mcg/hari) - Kortikosteroid sistemik - Tidak memiliki penurunan fungsi paru berat ($FEV1 \geq 60\%$ prediksi) - Tidak ada riwayat intubasi dan/atau perawatan ICU karena asma - Tidak ada eksaserbasi berat dalam 12 bulan terakhir - Tidak disertai komorbid yang termasuk ke PRB yang belum tertatalaksana dengan baik - Pasien tidak disertai komorbid yang tidak termasuk PRB
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi.
Daftar Pustaka	Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020. Tersedia dari www.ginasthma.org



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

J. PPOK

Rekomendasi	PAPDI dan PDPI
Klinis	1. Penilaian dilakukan secara klinis a. Pasien dengan skor mMRC (<i>Modified British Medical Research Council</i>) 0-1 atau skor CAT (COPD Assessment Test) kurang dari 10, DAN b. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak ada riwayat eksaserbasi 0 atau 1 kali (memerlukan rawat inap RS) atau > 1 kali tanpa perawatan RS 2. Pasien PPOK tidak disertai komorbid yang termasuk ke PRB yang belum tertatalaksana dengan baik 3. Pasien tersebut sudah di follow up dalam bulan dengan kondisi klinis baik tanpa komorbid, mengerti regimen pengobatan dan teknik inhaler yang digunakan dan mampu melakukan aktivitas fisik untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi
Daftar Pustaka	Global Initiative for Chronic Lung Disease (GOLD). Global Strategy for The Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2020

K. SLE

Rekomendasi PAPDI agar tidak dimasukkan ke dalam Program Rujuk Balik karena menurut SKDI : Kompetensi Dokter Umum untuk SLE adalah IIIA. Kasus SLE pada umumnya kompleks dan sulit diprediksi sehingga tidak dianjurkan untuk rujuk balik.

L. Skizofrenia

Rekomendasi	PDSKJI
Klinis	1. PANSS-remisi (P1,P2,P3,N1,N4,N6,G5,G9) semua skor komponen lebih kecil atau sama dengan 3; 2. Tercapai dosis fase rumatan antipsikotik; 3. Skizofrenia tanpa TACC (time= episode pertama, age= anak remaja dan usia lanjut, comorbidity= komorbiditas seperti ketergantungan zat, gangguan kepribadian, kondisi medis umum yang tidak terkendali, kasus forensik dll), complication = komplikasi seperti efek samping obat berat, deficit kognitif), 6 bulan tanpa kekambuhan;



**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN
TINGKAT PUSAT**

Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi
Daftar Pustaka	Surat Petunjuk Teknis Skizofrenia tentang Kriteria Rujuk dan Rujuk Balik dari PDSKJI ke Subdit Rujukan Bagian Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tanggal 22 Agustus 2019. Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 Tahun 2015 tentang PNPJ Jiwa.